

Os Traficantes de Drogas não são Vítimas dos Usuários: Uma Análise Multidisciplinar

Introdução

Recentemente, uma declaração pública gerou debates acalorados ao afirmar que “os traficantes são vítimas dos usuários [de drogas]”. A frase sugere que aqueles que comercializam drogas ilícitas seriam, em certa medida, “responsabilizados” ou até mesmo prejudicados pelos consumidores ¹. No entanto, ao examinarmos o fenômeno do tráfico de drogas através de múltiplas perspectivas – do direito à saúde pública –, evidencia-se que **os traficantes não podem ser vistos como vítimas dos usuários de drogas**. Pelo contrário, *traficantes são agentes atuantes que se beneficiam da demanda*, muitas vezes à custa de graves danos sociais. Este texto didático e abrangente explorará, de forma acessível, por que essa visão se sustenta, considerando aspectos jurídicos, sociológicos, econômicos, psicológicos, criminológicos e de saúde pública, entre outros.

Perspectiva Legal (Direito)

Do ponto de vista jurídico, a lei faz uma clara distinção entre usuários e traficantes de drogas, atribuindo papéis e responsabilizações muito diferentes a cada um. No Brasil, a **Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006)** estabelece que **portar drogas para consumo pessoal não acarretará prisão**, sendo previsto tratamento ou penas alternativas educativas para o usuário, enquanto o **tráfico de drogas é crime grave**, com longas penas de reclusão ² ³. Em outras palavras, *o usuário é tratado como alguém que precisa de ajuda, ao passo que o traficante é tratado como criminoso que causa dano coletivo*. Essa distinção legal reflete o entendimento de que o traficante não é uma “vítima” das escolhas do usuário, mas sim **um infrator que lucra e agrava o problema das drogas na sociedade**. A legislação brasileira – acompanhando convenções internacionais – considera o tráfico um delito grave porque ele alimenta um mercado ilícito que financia diversas outras atividades criminosas e gera violência. Portanto, sob a ótica do direito, **traficantes são considerados agentes criminosos e responsáveis por suas ações**, e não vítimas de terceiros.

Importante notar que a responsabilização penal diferenciada existe justamente pela diferença de conduta: o usuário, em geral, prejudica primariamente a si mesmo (daí muitas vezes ser visto mais como caso de saúde), enquanto o **traficante prejudica a coletividade ao difundir substâncias ilícitas e fomentar a criminalidade**. Em síntese, a lei reconhece o **traficante como perpetrador**, não havendo respaldo jurídico para classificá-lo como vítima dos consumidores de drogas. Pelo contrário, são os consumidores que frequentemente são vistos como parte vulnerável no contexto das drogas – por exemplo, usuários dependentes químicos podem ser tratados como doentes a serem reabilitados, ao passo que fornecedores ilícitos enfrentam punição legal.

Perspectiva Sociológica (Sociologia)

Sob a ótica da sociologia, o tráfico de drogas é um fenômeno complexo enraizado em **fatores sociais e econômicos**. Muitos indivíduos ingressam no comércio de drogas ilícitas em contextos de pobreza, falta de oportunidades de emprego e exclusão social. Estudos no Brasil indicam que aproximadamente **metade dos pequenos traficantes presos aponta dificuldades financeiras, dívidas e a necessidade**

de sustentar a família como motivos para entrar no tráfico ⁴. Em particular, uma pesquisa do Observatório das Favelas revelou que a **“motivação econômica, associada às dificuldades financeiras da família e à falta de acesso ao mercado de trabalho, aparece como o principal argumento”** para jovens ingressarem nas redes do tráfico ⁵. Esses dados mostram que, muitas vezes, **o traficante é um produto de contextos de vulnerabilidade social** – vítima, em todo caso, de desigualdades e da falta de políticas inclusivas, *não* dos usuários de drogas em si. Ou seja, do ponto de vista sociológico poder-se-ia dizer que alguns traficantes são, no máximo, **vítimas de um contexto social adverso**, mas não vítimas diretas dos consumidores.

É crucial destacar, porém, que **as consequências sociais do tráfico são devastadoras para a coletividade**. Comunidades pobres frequentemente sofrem sob o domínio de facções e quadrilhas do tráfico que impõem um regime de medo e violência. A presença do tráfico vem acompanhada de conflitos armados, aumento da criminalidade e corrosão do tecido social nas vizinhanças dominadas pelo comércio ilícito. No Brasil, *o tráfico de drogas tornou-se um fenômeno espalhado*, a ponto de **60% dos brasileiros relatarem ter testemunhado ou sabido de crimes ligados ao tráfico em sua vizinhança no último ano** ⁶ – um índice muito superior à média global (39%). Esses números mostram como o tráfico afeta de forma ampla a vida em sociedade, especialmente nas periferias urbanas. Longe de serem vítimas passivas, **os traficantes exercem poder local e contribuem para a insegurança e a desagregação social**, muitas vezes explorando a própria população em que se inserem.

Adicionalmente, sob o prisma sociológico, é enganoso inverter a relação de causa e efeito entre usuários e traficantes. **A demanda por drogas (usuários) e a oferta (traficantes) formam uma dinâmica de mercado ilícito**, mas isso não implica que o vendedor seja vítima do comprador – assim como um comerciante ilegal de armas não é vítima dos compradores de armas. Pelo contrário, muitos traficantes **aproveitam-se da demanda existente para obter ganhos econômicos**, ocupando um espaço deixado pela marginalização socioeconômica. Especialistas apontam que enfrentar de forma efetiva o problema do tráfico exige *transformações estruturais*, como **reduzir desigualdades, gerar empregos e melhorar a educação**, de modo a oferecer alternativas aos jovens em áreas vulneráveis ⁷. Essas medidas diminuem o recrutamento de novos traficantes e **enfraquecem o poder de atração do tráfico**, demonstrando que a raiz do problema está em fatores sociais e econômicos – não em uma suposta “opressão” sofrida pelo traficante por parte do usuário.

Aspectos Econômicos (Economia)

No campo econômico, o tráfico de drogas é essencialmente regido pela **lei da oferta e da procura**. Os usuários alimentam a demanda por substâncias ilícitas, e os traficantes suprem essa demanda em busca de lucro. Contudo, é equivocado interpretar essa relação mercantil como se os fornecedores fossem *coagidos* pelos consumidores – na verdade, **traficantes atuam de forma deliberada para explorar um mercado altamente lucrativo**. Estimativas globais mostram que o comércio ilegal de drogas movimenta somas astronômicas de dinheiro: o mercado global de drogas foi avaliado entre **US\$ 426 e US\$ 652 bilhões em 2014** ⁸, figurando como uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo, apenas atrás da falsificação. Esse montante colossal ilustra que **traficantes – especialmente os grandes chefes e cartéis – enriquecem às custas do vício alheio**, gerenciando um negócio clandestino que se espalha por vários países.

Os ganhos financeiros do tráfico não beneficiam a sociedade, muito pelo contrário. Segundo relatório da organização Global Financial Integrity, *“as receitas geradas... não trazem praticamente nenhum benefício de longo prazo para os cidadãos, comunidades ou economias”*, servindo apenas para **encher os bolsos dos perpetradores e financiar violência, corrupção e outros abusos** ⁹. Em vez de vítimas, os traficantes são **agentes econômicos racionais (embora ilegais)** que frequentemente **reinvestem**

seus lucros em atividades criminosas, comprando armas, corrompendo autoridades e expandindo suas redes. Essa perspectiva deixa claro que o traficante não sofre prejuízo imposto pelo usuário; **ao contrário, ele lucra intensamente em cima do consumidor**, mesmo sabendo que está vendendo produtos perigosos e destrutivos. Vale lembrar que, em economias ilícitas, práticas predatórias são comuns: por exemplo, alguns fornecedores *adulteram drogas com substâncias mais baratas e potentes* (como fentanyl misturado à heroína) para **aumentar seus lucros, mesmo que isso eleve o risco de overdose dos usuários**. Isso evidencia um fato simples: **no mercado de drogas, o interesse do traficante é o lucro, não o bem-estar do cliente**.

Outro ponto de vista econômico importante é que o tráfico de drogas impõe custos enormes à sociedade. Há custos diretos com segurança pública e sistema penitenciário para combater e punir o tráfico, assim como custos indiretos – perda de produtividade por dependência química, sobrecarga nos sistemas de saúde e prejuízos ao desenvolvimento local em áreas dominadas pelo crime. Traficantes não são vítimas desses custos; eles são, em larga medida, **os causadores**. Economistas e analistas de segurança argumentam que o tráfico funciona como um *imposto do crime* sobre comunidades: extrai dinheiro da população (usuários gastando em drogas) e **reverte esses recursos para atividades clandestinas** em vez de investimentos produtivos ou arrecadação tributária. Some-se a isso o fato de que a economia das drogas ilícitas está associada a uma série de *externalidades negativas*, como violência (que afugenta negócios legítimos), desvalorização imobiliária em bairros conflagrados e custos de tratamento de saúde pública. Em resumo, do ângulo econômico, **o traficante é um empreendedor do crime que explora um nicho lucrativo gerando enorme ônus social** – portanto não pode ser pintado como vítima dos consumidores que ele próprio decide suprir.

Aspectos Psicológicos (Psicologia)

Ao analisar a questão pelas lentes da psicologia, é fundamental distinguir as condições dos usuários de drogas e dos traficantes. **A dependência química é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS)**, uma condição crônica que altera o comportamento e cria compulsão pelo uso da substância ¹⁰. O usuário frequente (especialmente aquele que desenvolveu dependência) muitas vezes se encontra em posição de vulnerabilidade psicológica: pode ter perdido parte do controle sobre o uso, sofre sintomas de *abstinência* e tem o julgamento afetado pelo vício. *Em essência, o usuário com transtorno de uso de substâncias é visto pela medicina como um paciente, um indivíduo doente que precisa de tratamento e apoio*, não de punição moral. Os traficantes, por outro lado, **não sofrem de uma compulsão involuntária para vender drogas** – sua motivação é diferente. Traficar é uma **escolha deliberada**, muitas vezes calculada, para obter ganho material ou status dentro de um grupo criminoso. Nesse sentido, sob o enfoque psicológico, **o traficante apresenta um comportamento pró-ativo e intencional**, distinto do comportamento do dependente, que pode estar agindo sob coerção da própria neuroquímica alterada pela droga.

Há até um dito conhecido no submundo do crime: *“quem vende, não usa”*. Muitos traficantes evitam consumir as drogas que comercializam, seja para não chamar a atenção, seja porque reconhecem os efeitos devastadores do vício – o que demonstra certa consciência e frieza sobre o que estão fazendo. Por exemplo, registros de entrevistas com narcotraficantes revelam clinicamente que *“o que vende, não consome”*, deixando claro que eles veem o uso apenas para os **“outros”** (os clientes), enquanto mantêm a si mesmos fora daquele dano ¹¹. Em termos psicológicos, isso denota **um grau de cálculo e manipulação** incompatível com a ideia de que estariam subjugados pelos usuários. Na verdade, a relação psicológica vai no sentido inverso: **traficantes frequentemente manipulam e exploram os usuários**, atizando o consumo para aumentar seus ganhos. Segundo a Interpol, *os dependentes e usuários finais são frequentemente vítimas de um negócio poderoso e manipulador* mantido pelos traficantes ¹². Essa observação ressalta como **traficantes aplicam estratégias de coerção e persuasão**, podendo oferecer amostras grátis ou “brindes”, conceder fiado e expandir seu mercado,

tudo para **prender psicologicamente o usuário no ciclo de consumo**. Claramente, do ponto de vista da saúde mental e do comportamento, o traficante assume o papel análogo ao de um **predador**, não de uma presa.

Também é válido mencionar que, embora alguns indivíduos envolvidos no tráfico possam ter históricos de trauma, abuso ou outras vulnerabilidades psicológicas (muito comuns em populações carcerárias), isso não os torna vítimas dos usuários. Pelo contrário, muitos traficantes desenvolvem uma *insensibilidade ou indiferença* em relação ao sofrimento alheio – traço associado a distúrbios de personalidade antissociais. A violência extrema empregada por certos traficantes contra devedores, rivais ou até clientes inadimplentes exemplifica traços de crueldade e falta de empatia. *Na psicologia criminal, traficantes de alta periculosidade às vezes preenchem critérios de psicopatia, exibindo charme superficial, manipulação e ausência de remorso.* Isso reforça que **não há inversão de papéis morais: é o usuário dependente quem costuma ser enganado e explorado, enquanto o traficante implacável segue em frente visando apenas seu interesse**. Assim, da perspectiva psicológica, não encontramos respaldo para a ideia de traficante como “vítima” do usuário, mas sim para o traficante como **figura ativa que conscientemente perpetua o ciclo de abuso de drogas**.

Visão da Criminologia

A criminologia aprofunda a compreensão do tráfico de drogas enquanto fenômeno do crime organizado. **Traficantes de drogas, especialmente em nível médio e alto, fazem parte de redes criminosas estruturadas**, com divisão de tarefas (produtores, transportadores, distribuidores, “gerentes” do tráfico, varejistas, etc.) e uso sistemático de violência e intimidação. Sob essa ótica, é absurdo classificar tais atores como vítimas dos usuários – *traficantes são, antes, vitimários*, ou seja, **são eles que produzem vítimas na sociedade**, direta e indiretamente. Como declarou enfaticamente o ministro boliviano Eduardo del Castillo ao rebater a romantização de um grande narcotraficante: *“(os narcos) no son víctimas, son victimarios, destruyen las economías, perjudican...”* – ou seja, traficantes **“não são vítimas, são algozes”, que destroem economias e causam prejuízos** ¹³. De fato, o crime do tráfico vem acompanhado de uma esteira de violência. Disputas entre facções rivais por pontos de venda ou rotas de tráfico resultam em homicídios, chacinas e toda sorte de atos violentos. **Muitos homicídios registrados nas estatísticas policiais estão relacionados, direta ou indiretamente, ao comércio de drogas** – seja brigas de gangues, seja assassinatos de usuários devedores ou confrontos da polícia com traficantes. Por exemplo, no México e em outros países afetados por cartéis, dezenas de milhares de mortes nos últimos anos são atribuídas à chamada “guerra às drogas”. No Brasil, estimativas já sugeriram que cerca de **1/3 das mortes violentas podem estar ligadas ao contexto do combate e comércio de drogas ilícitas** (entre confrontos armados, acertos de conta e intervenções policiais). *Esses números traduzem tragédias humanas causadas pela atividade dos traficantes*, o que inviabiliza enxergá-los como coitados ou inocentes diante dos consumidores.

Além da violência letal, **traficantes fomentam uma série de outros crimes**. A Interpol e outros órgãos de segurança documentam que **o tráfico de drogas costuma vir associado a crimes conexos como lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de armas** ¹⁴. Para escoar os lucros imensos, traficantes corrompem agentes públicos, infiltram-se em instituições e empregam esquemas sofisticados de lavagem, minando a governança e a economia formal. A compra de armas ilegais alimenta um círculo vicioso de poder bélico nas mãos do crime organizado, aumentando o potencial de violência contra rivais e contra o Estado. Há também ligação com o tráfico de pessoas, já que facções utilizam comunidades vulneráveis para recrutamento e exploração, e com outros mercados ilícitos. Em suma, **traficantes de drogas são protagonistas de um ecossistema criminoso bem mais amplo**, que produz vítimas em inúmeros setores da sociedade – das famílias enlutadas pela violência aos jovens aliciados pelo crime, dos usuários dependentes aos moradores sitiados em comunidades dominadas.

Do ponto de vista criminológico, ao se afirmar que “traficantes são vítimas dos usuários”, corre-se o risco de **inverter papéis de responsabilidade**, o que não condiz com a realidade factual investigada. Traficantes exercem seu arbítrio ao entrar e permanecer na carreira criminosa, e embora muitos venham de circunstâncias socioeconômicas difíceis (como já abordado na seção sociológica), isso *não exime a culpabilidade pelos atos cometidos*. A criminologia moderna reconhece que fatores sociais influenciam a criminalidade (teorias como **strain** ou anomia explicam a entrada no crime pela desigualdade, por exemplo), mas nem por isso se considera que o criminoso seja uma “vítima” de terceiros específicos – há sempre a dimensão da escolha e da ação consciente. No caso do tráfico, vários estudos revelam que *os indivíduos engajados nessa atividade demonstram saber dos riscos e da ilicitude*, mas seguem em frente pelos benefícios percebidos (dinheiro, status, poder) ⁴. Assim, a responsabilidade criminal recai sobre eles. **Traficantes impõem um regime de terror em alguns locais, cooptam menores de idade, ordenam execuções** – difícil imaginar característica menos compatível com a ideia de vítima. Pelo contrário, no imaginário das ciências criminais, eles figuram como *agressores sociais*. Não por acaso, a sociedade e o Estado buscam meios de coibir sua ação: políticas de segurança, operações policiais e cooperação internacional são direcionadas a combater essas organizações. Em conclusão, a criminologia reforça que **traficantes de drogas são autores de crime que causam vitimização difusa na sociedade**, e não vítimas de usuários ou de meros infortúnios.

Perspectiva de Saúde Pública

Na esfera da saúde pública, a distinção de papéis entre usuários e traficantes é fundamental para o desenho de políticas eficazes. **Usuários de drogas – especialmente os dependentes – são tratados como questão de saúde**, demandando estratégias de redução de danos, tratamento médico e reinserção social. Já **o tráfico de drogas é visto como uma ameaça à saúde coletiva**, pois amplia o acesso a substâncias nocivas, dificulta o controle de qualidade (levando a produtos adulterados mais perigosos) e dissemina epidemias. Um exemplo gritante é a atual crise de opioides em países como os Estados Unidos: *traficantes têm introduzido o fentanil (opioide sintético extremamente potente) na cadeia de fornecimento*, resultando em um surto de overdoses fatais. Apenas em 2022, **mais de 107 mil pessoas morreram por overdose nos EUA** – um número sem precedentes, atribuído em grande parte à proliferação de opiáceos ilícitos como o fentanil no mercado negro ¹⁵. Por trás dessa estatística sombria está a ação de fornecedores inescrupulosos que misturam e distribuem drogas altamente letais, colocando em risco milhares de vidas. Isso demonstra como, do ponto de vista da saúde, **são os usuários que se tornam vítimas (às vezes fatais) das substâncias disponibilizadas pelos traficantes**, invalidando completamente a ideia de que ocorreria o contrário.

Em escala global, as drogas ilícitas causam um grande impacto sanitário. Segundo dados das Nações Unidas, cerca de **585 mil mortes por ano estão associadas ao uso de drogas** (dado de 2017), sendo mais da metade dessas mortes resultantes de **overdoses e doenças como hepatite C contraídas pelo uso de drogas** – eventos em sua maioria preveníveis ¹⁶. Ou seja, centenas de milhares de pessoas morrem anualmente devido a condições ligadas à drogadição, uma tragédia de saúde pública. Quem cria as condições para essas mortes? Certamente **não é o usuário**, que figura entre as vítimas nas estatísticas. A responsabilidade recai sobre o sistema ilegal que fornece as substâncias sem qualquer controle. *Ao vender droga, o traficante está distribuindo um produto que causa doença e morte*, sem rótulos, sem dose segura, sem orientação – pelo contrário, muitas vezes instigando o consumo exagerado. Isso configura um problema de saúde pública gravíssimo: comunidades enfrentam ondas de dependência (ex.: epidemias de crack), sistemas de saúde lidam com sobrecarga de pacientes com transtornos por uso de substâncias, e governos precisam lançar campanhas e programas para mitigação dos danos. **Traficantes contribuem diretamente para esses males coletivos**, aumentando a disponibilidade de drogas nas ruas e dificultando estratégias de prevenção. Por isso, políticas

modernas de drogas frequentemente combinam ações de saúde (tratamento de usuários) com *ações de repressão ao tráfico (redução da oferta)* – reconhecendo cada qual seu papel.

Outro fator de saúde pública é que o tráfico alimenta a propagação de doenças transmissíveis. Em mercados ilícitos, usuários muitas vezes compartilham seringas (no caso de drogas injetáveis), aumentando a transmissão de HIV/Aids e hepatites. Programas governamentais de redução de danos distribuem agulhas descartáveis para evitar isso, mas traficantes ou “milícias” do tráfico em alguns lugares desencorajam essas iniciativas ou se opõem a clínicas de tratamento em seus territórios. Em outros casos, traficantes dominam uma região a tal ponto que serviços de saúde têm dificuldade de atuar. Assim, *o tráfico se torna um obstáculo à saúde comunitária*, agravando crises sanitárias. Por exemplo, em zonas controladas por facções, as “Cracolândias” se estabelecem – aglomerações de usuários em condições insalubres –, e as tentativas de intervenção exigem negociação ou operações de força para adentrar essas áreas. Tudo isso reforça a assimetria da equação: **o usuário adoece; o traficante prospera com a doença alheia**. Em suma, na perspectiva da saúde pública, **o traficante é vetor de agravos à saúde, não alvo de prejuízos causados pelo usuário**. As autoridades sanitárias focam em **proteger a população (inclusive os usuários) dos efeitos do tráfico**, seja através de educação, restrição à oferta de drogas ou tratamento, deixando claro quem é o elemento prejudicial nessa dinâmica.

Considerações Finais

A análise multidisciplinar deixa evidente que **os traficantes de drogas não são vítimas dos usuários**, mas sim protagonistas – e beneficiários – de um ciclo de crime e sofrimento humano. Sob a luz do **Direito**, traficantes são criminosos que afrontam a lei e causam danos coletivos, recebendo punições severas distintas do tratamento dado aos usuários. Pela **Sociologia**, entendemos que embora muitos traficantes sejam oriundos de contextos sociais precários (sendo, nesse sentido, vítimas da desigualdade), isso não os torna vítimas de usuários; ao contrário, eles exercem domínio sobre comunidades e alimentam problemas sociais. A **Economia** demonstra que traficantes exploram a demanda dos usuários para obter lucros exorbitantes, financiando violência e não trazendo benefício algum à sociedade. A **Psicologia** diferencia o dependente (doente) do traficante (agente manipulador e consciente), mostrando que é o usuário quem geralmente está em posição de vulnerabilidade. A **Criminologia** confirma que traficantes integram organizações responsáveis por extensa vitimização social – violência, corrupção, mortes –, não havendo inversão de papéis onde eles seriam inocentes lesados pelos consumidores. E a **Saúde Pública** reforça que o tráfico amplia os malefícios à saúde da população, causando epidemias de dependência e milhares de mortes por ano, enquanto traficantes agravam esses problemas para auferir vantagem.

Em todas essas áreas do conhecimento, o consenso é que **traficantes são agentes causadores e amplificadores do problema das drogas**, e não vítimas dele. Dizer que o traficante é vítima do usuário seria como dizer que o fornecedor de veneno é vítima de quem o compra – uma distorção que ignora a responsabilidade e o poder de quem está na posição de fornecer e lucrar. Isso não significa que devamos desconsiderar as raízes sociais do tráfico ou deixar de tratar usuários com humanidade; na verdade, a solução abrangente envolve **responsabilizar traficantes com vigor, ao mesmo tempo em que se oferecem oportunidades e tratamento para usuários**. Sociólogos e especialistas sugerem que **investir em reduzir a pobreza e a desigualdade** (gerando empregos, educação de qualidade, inclusão social) pode **prevenir o ingresso de jovens no tráfico e reduzir a violência** associada ⁷. Paralelamente, políticas de saúde que tratam a dependência química como doença – com apoio psicológico, psiquiátrico e programas de reabilitação – ajudam a **diminuir a demanda** e salvar vidas, sem precisar recorrer à culpabilização do dependente. Assim, a sociedade consegue **enfrentar simultaneamente os dois lados do problema: reduzir o número de vítimas (usuários doentes) e enfraquecer os algozes (traficantes e suas redes)**.

Em conclusão, é imprescindível compreender que **traficantes não são vítimas dos usuários, mas sim coautores de um ciclo destrutivo**. Eles se aproveitam da procura por drogas, assumindo riscos calculados e muitas vezes impondo enormes custos humanos aos outros. Todas as áreas analisadas – do direito à saúde – corroboram a necessidade de **responsabilizar quem trafica e acolher/educar quem consome**, desmontando a narrativa inversa. Somente com essa clareza de papéis podemos adotar políticas justas e eficazes: punir e combater o tráfico, ao mesmo tempo em que **educamos a população, tratamos os dependentes e atacamos as causas sociais** que alimentam esse mercado ilícito. Dessa forma, estaremos protegendo potenciais vítimas reais (usuários e comunidades) e focando em **diminuir o poder e a influência dos verdadeiros culpados – os traficantes e as organizações criminosas**, construindo uma sociedade mais segura e saudável para todos.

Fontes: As informações apresentadas foram fundamentadas em dados e análises atuais de diversas áreas. Destacam-se declarações recentes do presidente brasileiro sobre tráfico e usuários ¹, artigos legais e explicações sobre a Lei de Drogas no Brasil ² ³, relatórios de organizações internacionais sobre o impacto econômico e social do narcotráfico ⁹ ¹², estudos sociológicos sobre o perfil de envolvidos no tráfico ⁴, pesquisas de percepção pública da criminalidade ligada às drogas ⁶, pronunciamentos de autoridades e especialistas em segurança e saúde pública ¹³ ¹⁰, além de estatísticas globais atualizadas sobre uso de drogas, mortalidade e violência correlacionada ¹⁶ ¹⁵. Essas referências corroboram a visão multidisciplinar de que, em 2025, **permanece claro que traficantes de drogas não são vítimas de usuários, mas sim agentes ativos e responsáveis pelos graves problemas associados às drogas ilícitas**.

¹ Lula: traficantes são vítimas dos usuários também

<https://www.gazetadopovo.com.br/republica/lula-traficantes-sao-vitimas-dos-usuarios-tambem/>

² ³ Qual A Diferença De “usuário” E “traficante”? | Brasil De Direitos

<https://www.brasildedireitos.org.br/atualidades/ittc-explica-como-o-judicio-distingue-usuario-de-traficante/>

⁴ ⁵ ojs.defensoria.sp.def.br

<https://ojs.defensoria.sp.def.br/index.php/RDPSP/article/download/130/64/>

⁶ ⁷ Seis a cada dez brasileiros afirmam que há tráfico de drogas em sua vizinhança | Ipsos

<https://www.ipsos.com/pt-br/seis-cada-dez-brasileiros-afirmam-que-ha-trafico-de-drogas-em-sua-vizinhanca>

⁸ ⁹ Transnational Crime and the Developing World - Global Financial Integrity

<https://gfinetegrity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/>

¹⁰ Dependência química é doença e tem tratamento — Agência Gov

<https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202402/dependencia-quimica-e-doenca-e-tem-tratamento>

¹¹ ¹³ Del Castillo tras entrevista a Marset: 'no es una víctima, sino victimario, acostumbrado a mentir'

<https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/castillo-entrevista-marset-es-victima-victimario-acostumbrado-mentir/20231127120648928780.html>

¹² ¹⁴ Drug trafficking

<https://www.interpol.int/en/Crimes/Drug-trafficking>

¹⁵ Drug Overdose Deaths in the United States, 2002–2022 - CDC

<https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db491.htm>

¹⁶ UN World Drug Report shows flourishing global drug market but remains silent on policy failures and human rights abuses - International Drug Policy Consortium (IDPC)

<https://idpc.net/press/2020/06/un-world-drug-report-shows-flourishing-global-drug-market-but-remains-silent-on-policy-failures-and-human-rights-abuses>